Exploración renal, tacto rectal y examen de orina

SEMIOLOGIA · Clase 34 · Giordano, globo vesical, tacto rectal y lo que dice la orina

1 · PUÑO-PERCUSIÓN: SIGNO DE GIORDANO Y ABSCESO PERINEFRÍTICO

F1 **Puño-percusión lumbar**
mano izquierda abierta sobre la región lumbar alta y media (ángulo costovertebral)

sobre ella se da el

F1 **Golpe con el puño derecho**
seco y moderado sobre el dorso de la mano izquierda; se comparan ambos lados

si provoca dolor es

F1 **Giordano positivo**
el golpe desencadena dolor: la cápsula de un riñón inflamado se sacude

orienta a un

F1 **Proceso renal inflamatorio**
pielonefritis aguda o absceso perinefrítico

si el pus pasa a la grasa hay

F2 **Absceso perinefrítico**
el pus sale a la grasa perirrenal: abombamiento lumbar con tumor, calor, rubor, dolor y posible fluctuación

pero antes se descarta lo

Contractura, artrosis o hernia discal también duelen: se compara y se descarta lo extrarrenal

se completa con

2 · PALPAR EL TRAYECTO: PUNTOS URETERALES Y RIÑÓN

Riñón normal
solo es palpable el polo inferior derecho; más fácil en delgados y multíparas, difícil en obesos

se busca con las

Tres técnicas de palpación renal
bimanual (decúbito dorsal), Guyon o rechazo (impulsos lumbares) e Israel (decúbito lateral)

si no se palpa se completa con

Lo que la palpación no descarta se completa con ecografía o tomografía (no palpar un cálculo no lo descarta)

F3 **Puntos ureterales**
se palpan en el trayecto del uréter; tu docente: borde externo de los rectos (superior, medio e inferior: literatura 🐚)

si duele orienta a

F3 **Dolor en el punto ureteral**
orienta a cólico renal

se confirma con

la HBP es indicación del

3 · LA VEJIGA: GLOBO VESICAL

F4 **Inspección**
distensión por encima del ombligo

F4 **Palpación**
masa dolorosa, firme, periforme, continua con la sínfisis; la vejiga normal no se palpa

F4 **Percusión**
matidez en el hipogastrio

sugiere el

sugiere el

sugiere el

F4 **Globo vesical**
retención urinaria, típica de la HBP en mayores de 60 años

se confirma cuando

F4 Se confirma porque desaparece al evacuar la vejiga

4 · TACTO RECTAL: TÉCNICA Y ESTRUCTURAS

se realiza con la

F5 **Preparación**
explicar el examen; genupectoral o decúbito dorsal con rodillas flexionadas; guantes y vaselina líquida; inspeccionar el ano

luego se hace la

F5 **Entrada del índice**
con rotación, unos 10 cm más allá del borde anal

por delante en el varón palpa

por delante en la mujer palpa

por detrás palpa el

al salir se mira el

F6 **Pared anterior, varón**
próstata y vesículas seminales

F6 **Pared anterior, mujer**
cuello uterino y fondo de saco de Douglas

F6 **Pared posterior**
promontorio sacrococcígeo

F5 **Al retirar el dedo**
se mira el guante: heces, pus o sangre (melena)

por eso completa el estudio

por eso completa el estudio

por eso completa el estudio

también completa el estudio

con el resto se hace el

El tacto completa el estudio de la patología prostática y pélvica

5 · TACTO RECTAL: INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

F7 **De rutina en**
HBP, patología digestiva baja, fístula anal, tumores rectales, abscesos anorrectales, ganglios retroperitoneales, útero grávido y anexos, fecaloma, megacolon chagásico

en el varón se hace de rutina desde los

F7 **Varón mayor de 50 años**
Sotomayor 2020; Sotito 2018 dice mayores de 40

salvo si hay

F6 Contraindicado en la fisura anal y la trombosis hemorroidal: dolor intenso

6 · LA MUESTRA DE ORINA Y LA TIRA REACTIVA

F8 **Muestra ideal**
primera orina de la mañana, chorro medio (se desecha el primer chorro), frasco estéril

se cultiva para el

permite detectar la

permite medir el

permite detectar la

F8 **Urocultivo con antibiograma**
diagnostica bacteriuria y orienta el antibiótico

F11 **Glucosuria**
normalmente ausente

si es abundante

F9 **pH urinario**
ácido, 4,5 a 7

F10 **Proteinuria**
normal hasta 150 mg/24 h; por encima es siempre renal; el paciente nota orina con espuma

se interpreta en la

si es escasa

F11 · F12 **Abundante**
diabetes descompensada; en la obesa deshidratada que orina mucho se busca glucosuria

si pasa del límite orienta a

se eleva por

F10 **Causas**
nefrótico (3,5 g/24 h o más), nefrítico, nefropatía diabética (microalbuminuria precoz), insuficiencia renal

F11 **Escasa**
insuficiencia renal avanzada o síndrome de Fanconi

si se mide con Benedict, ojo con la

se interpreta en la

se interpreta en la

se interpreta en la

F9 **Alcalinización**
dieta o gérmenes con ureasa (urea a amoníaco); en orina alcalina precipitan fosfatos

se interpreta en la

se interpreta en la

F13 **Reacción de Benedict**
marca cualquier azúcar reductor (galactosa, lactosa, fructosa, pentosa); la glucosa-oxidasa sí es específica (🐚)

se interpreta en la

La tira y el cultivo dirigen el sedimento y la función renal

7 · SEDIMENTO Y CILINDROS

Sedimento
centrifugar 10 ml, 5 min a 1.500 rpm

permite contar los

permite reconocer los

permite contar los

Leucocitos
normal hasta 3 por campo; más de 10 sugiere infección urinaria

Cilindros
moldes de proteína tubular coagulada; se clasifican por lo que arrastran

Hematíes
normal hasta 2 por campo; pueden subir sin lesión renal con fiebre, ejercicio o coagulopatía

si arrastran poca albúmina son

si el daño es crónico son

si la infección sube al riñón dan

si arrastran leucocitos son

si arrastran hematíes son

si vienen del glomérulo forman

Hialinos
aislados, sin significado patológico

Céreos
glomerulonefritis crónica

Leucocitarios
pielonefritis o nefritis intersticial

Hemáticos
el hallazgo más importante: típicos del síndrome nefrítico (lámina 35)

aislados no cuentan para la

señalan daño glomerular en la

señalan inflamación en la

señalan lesión glomerular en la

El tipo de cilindro separa inflamación intersticial de lesión glomerular

técnica · signo · diagnóstico · complicación · desenlace · concepto · causa · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 10b · Exploración genitourinaria y exámenes complementarios (y 09b puntos ureterales) — teoría del docente (Sotomayor 2020; Sotito 2018); 🐚 = literatura